

ДИАГНОСТИКА

УДК:616.6-07

Г.С.Ахметова, Ж.Ж.Жолдыбай

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ГОРТАНИ

Аннотация. В статье представлены возможности мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике рака гортани. Проведен анализ результатов компьютерно-томографического исследования пациентов с подозрением на рак гортани с изучением локализации, распространенности процесса, состояния окружающих органов и тканей.

Ключевые слова: рак гортани, мультиспиральная компьютерная томография.

Введение. Рак гортани – злокачественное новообразование, происходящее из эпителиальной ткани. В структуре всех злокачественных опухолей рак гортани составляет около 3%, занимает первое место среди злокачественных опухолей головы и шеи. Преимущественно встречается у мужчин (80-95%). К факторам риска относятся: курение, злоупотребление алкоголем, работа в условиях запыленности, повышенной температуры, увеличение в среде концентрации канцерогенных веществ (бензола, нефти и ее продуктов, табачного дыма). Особое значение в возникновении рака гортани имеют предраковые заболевания – хронический ларингит, длительно существующая папиллома, лейкоплакия слизистой оболочки гортани, пахидермия, фиброма гортани. Около 95% опухолей гортани – плоскоклеточный рак. Другие гистологические типы злокачественных опухолей гортани – *carcinomain situ* (внутриэпителиальный рак), аденокарцинома, недифференцированный рак. Метастазирование рака гортани чаще происходит лимфогенным путем.

Материал и методы. В отделении лучевой диагностики КазНИИОиР проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 91 пациенту с подозрением на рак гортани. Все случаи были патоморфологически подтверждены. Возраст пациентов от 32 до 78 лет, средний возраст составил – 46 лет. Исследования проведены на 64-срезовом КТ с болюсным введением контрастного препарата.

Результаты и обсуждение. При анализе результатов компьютерной томографии – опухоли надгортанника вы-

явлены у 3(3%), надсвязочного пространства у 11(12%), вестибулярного аппарата у 21(23%), подсвязочного пространства у 10(11%) пациентов. В 19 (21%) случаях процесс охватывал надсвязочное пространство и вестибулярный аппарат, в 22 (24%) случаях вестибулярный аппарат и подсвязочное пространство; в 5 (5%) случаях имелось тотальное поражение гортани, с распространением процесса в мягкие ткани шеи. Из 27 пациентов с поражением вестибулярного аппарата и подсвязочного пространства, тотальным поражением в 11 (41%) случаях имелось вторичное поражение хрящей гортани (перихондрит) в виде эрозирования и литической деструкции; у 4 (15%) пациентов – метастатическое поражение шейных позвонков в виде литической деструкции.

Опухоли гортани визуализировались как локальное или диффузное утолщение стенок различной степени выраженности; образования с экзофитным компонентом в просвете, суживающие просвет воздухоносных путей. После контрастного усиления отмечалось неинтенсивное неомогенное накопление контрастного вещества измененными стенками, образованиями и экзофитным компонентом.

У 88 (97%) пациентов при МСКТ визуализировались лимфатические узлы мягких тканей шеи: у 21 (24%) – множественные, размеры которых не превышали 1,0 см в диаметре (в пределах нормы), в 67 (76%) случаях – гиперплазированные лимфоузлы от 1,2 см в диаметре до крупных конгломератов. После контрастного усиления гиперплазированные лимфоузлы накапливали контрастное вещество капсулой.

У пациентов с конгломератами гиперплазированных лимфоузлов в 29 (43%) случаях в процесс были вовлечены общая сонная артерия и ее ветви, яремные вены.

Выводы. Таким образом, мультиспиральная компьютерная томография с контрастным усилением при раке гортани позволяет уточнить локализацию, распространенность процесса, состояние хрящевых структур, сосудов шеи, наличие метастатического поражения лимфатических узлов шеи, что имеет важное значение при выборе адекватного метода лечения.

Список литературы

1. Абисатов К. Клиническая онкология.- Алматы: АРЫС, 2007.- Т. 1,2.
2. Сперанская А.А., Черемисин В.М. Компьютерно-томографическая диагностика новообразований глотки, челюстно-лицевой области и гортани.- СПб: Элби-СПб, 2006.
3. Прокоп М., Галански М. Спиральная многослойная компьютерная томография.- М.: МЕДпресс-информ, 2007.
4. Burgener F.A., Hercog C., Meyers S.P., Zaunbauer W. Differential Diagnosis in Computed Tomography, Thieme.- Stuttgart-NewYork, 2011.

Тұжырым

Г.С.Ахметова, Ж.Ж.Жолдыбай**Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институты****Мультиспиралды компьютерлік томографиямен көмейдің қатерлі ісігін анықтау**

Мақалада көмейдің қатерлі ісігін анықтаудағы мультиспиралды компьютерлік томографияның мүмкіндіктері көрсетілген. Көмейдің қатерлі ісігіне күдікті науқастардың компьютерлік томография зерттеуінің нәтижелері талданып, процестің орналасуы, таралуы, қоршаған ағзалар мен тіндерге таралуы талқыланды.

Түйінді сөздер: көмейдің қатерлі ісігі, мультиспиралды компьютерлік томография.

Summary

G.S.Ahmetova, Zh.Zh.Zholdybay**Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and Radiology****Multislice computed tomography in the diagnosis of laryngeal cancer**

The article presents possibilities of multislice computed tomography in the diagnosis of laryngeal cancer. The analysis of the results of computed tomography scans for patients with suspected laryngeal cancer with definition of localization, prevalence of the process, condition of the surrounding organs and tissues.

Keywords: laryngeal cancer, multislice computed tomography.